

DSA Parte 2 e Polyhandicap — Sintesi

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 09

Lezione divisa in due: aspetti professionali dell'ASD + introduzione al polyhandicap. Due utenze diverse, stesso principio di fondo — osservare, capire, costruire. Ce la fai.

ASD — Diagnosi funzionale e lavoro educativo

- La **diagnosi medica** (livello 1-2-3) non guida il lavoro educativo
- Conta la **diagnosi funzionale** (analisi funzionale): come funziona *questa* persona nel *suo* contesto
- L'analisi funzionale considera: difficoltà, capacità residue, **potenzialità di sviluppo** — *qui si costruiscono gli obiettivi*

Le 5 aree del PEI

- **Abilità motorie** — base di tutto; l'apprendimento parte dal corpo
- **Autonomie personali** — dipendono dalla motricità fine e dallo sviluppo corporeo
- **Apprendimenti scolastici** — parte del progetto di vita
- **Abilità sociali** — le più critiche (strumentali + relazionali, *Castaldo et al., 2021*)
- **Comunicazione** — area fondamentale; va lavorata partendo dai prerequisiti

Abilità vs. Competenze sociali

- **Abilità**: comportamenti specifici appresi (*es. salutare*)
- **Competenza** (*Keller, 2021*): usare quell'abilità nel contesto giusto, gestire le relazioni, le emozioni, le funzioni metacognitive

- Ostacoli alle competenze sociali: fattori neurobiologici, comorbidità psichiatriche (ansia/depressione), mancanza di motivazione

Prerequisiti della comunicazione

Da lavorare in ordine di complessità crescente:

- **Percezione sensoriale** — ascoltare, osservare
- **Interazione sociale** — interesse per l'altro
- **Imitazione** — difficoltà tipica nell'ASD
- **Gestualità** — precede il linguaggio verbale
- **Attenzione condivisa** — obiettivo enorme e fondamentale
- **Intento comunicativo** — voler comunicare
- **Sviluppo cognitivo** — pattern, memoria, associazioni

Quando la comunicazione verbale non è raggiungibile → **CAA** (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), es. **PECS** con carte-immagine.

Le **7 funzioni linguistiche di Halliday (1975-1980)** guidano il lavoro sulle forme comunicative: strumentale, regolatoria, interazionale, personale, euritmica, referenziale, immaginativa.

Come si lavora nell'ASD

- **Training quotidiani e ripetuti** — non basta una volta a settimana; va fatto da tutti (scuola, casa, istituto)
- **Metodologia strutturata e direttiva** — niente improvvisazione
- **Rete allargata** — i genitori sono parte centrale dell'intervento

Strategia chiave: **abbassare prima l'ansia** con prevedibilità e struttura del tempo, *poi* iniziare il training.

I comportamenti problema hanno una funzione comunicativa → non si sopprimono, si sostituiscono con comportamenti alternativi (**valutazione funzionale**).

La **motivazione** è leva principale: **si parte dagli interessi della persona, non da ciò che vuole insegnare l'educatore.**

Approcci principali

Approccio	Autore/Anno	Fulcro
ABA	Skinner	Rinforzo in setting 1:1
Approcci naturalistici	Koegel et al. (1979)	Apprendimento nell'iniziativa spontanea del bambino
CBT	Ellis e Beck, anni '60	Pensieri, emozioni, comportamenti disfunzionali
Training abilitativi	Moderato	Abilità specifiche da bilancio funzionale
CAA / PECS	—	Comunicazione alternativa al verbale
TEACCH	Schopler (1972)	Struttura visiva, ambiente adattato
Approcci evolutivi	—	Reciprocità sociale, imitazione, attenzione condivisa
ESDM (Denver)	Rogers e Dawson	Parent training + ABA + sviluppo; da 12 mesi

Lavorare con le famiglie nell'ASD

- Coinvolgerle attivamente nel PEI
- **Parent training** come parte dell'intervento
- Relazione basata su fiducia, rispetto, coerenza — no pietà, no giudizio
- Considerare le priorità e le competenze della famiglia, non solo i bisogni del figlio

Rischi professionali da evitare: terapie di moda, improvvisazione, visione a corto termine, esclusione della famiglia, assistenzialismo.

Polyhandicap — Definizione e caratteristiche

- Deficit grave, ad **espressioni multiple**, che associa sempre:
 - **Deficit fisico importante**
 - **Deficit intellettuale severo o profondo**
- Conseguenza di un **danno cerebrale grave e incurabile** avvenuto prima dei **3 anni**
- **Evolve nel tempo — non è statico**

Le 5 dimensioni AAIDD nel polyhandicap

Dimensione	Caratteristica
Funzionamento intellettuale	Profondo; sviluppo paragonabile a bebè di 6 mesi (periodo senso-motorio Piaget, stadi 1-4)
Funzionamento adattivo	Dipendenza totale (cure, alimentazione); comunicazione solo non verbale
Salute	Polipatologie gravi, epilessia frequente , tasso mortalità elevato
Interazione/partecipazione	Interazioni inesistenti o povere; dipendenza totale
Contesto	Équipe pluridisciplinare; esigenze etiche massime

Sostegni necessari: livello **maggiore e intensivo** ([AAMR, 2002](#)).

Salute e dolore

- **Motricità fortemente ristretta** → conseguenze su postura, respirazione, struttura ossea

- Dolore in 4 forme: dolori comuni, da polipatologia, mentale, da cure quotidiane
- **I cambiamenti di comportamento** spesso nascondono dolore fisico non comunicato
- **Epilessia frequente:** dopo crisi, la persona può dormire 24h → adeguarsi, non forzare

Comunicazione nel polyhandicap

- **Comprensione** viene sempre prima della **produzione**
- **Chi non produce non significa che non comprenda** — errore comune e grave
- La comunicazione non verbale (sguardo, gesti minimi) è spesso il canale principale
- **Si lavora su causalità elementare (es. campanelle) → base per agire sull'ambiente → base per comunicare**

Famiglie e professionisti

- Sostegno ai genitori in tutti i momenti chiave: diagnosi, informazioni, servizi, vita adulta
- L'équipe pluridisciplinare è indispensabile — **mai soli** con questo tipo di utenza
- **Dimensione etica:** persone non verbali, non possono segnalare abusi — supervisione e cultura istituzionale sono garanzie fondamentali

Da ricordare:

- **Analisi funzionale** — non la diagnosi medica, ma *come funziona questa persona* guida il lavoro
- **Attenzione condivisa** — prerequisito fondamentale della comunicazione; senza non si costruisce niente
- **Polyhandicap** — danno cerebrale precoce incurabile; deficit intellettivo profondo + fisico grave; presa a carico globale per migliorare la qualità di vita